

Il Corpo Sessuato

Salute Mentale · Sessione 10

Una lezione che ti porta a guardare la sessualità con occhi completamente nuovi: non solo come atto fisico, ma come dimensione centrale dell'identità umana, con radici nell'infanzia, una storia scientifica ricca alle spalle e un catalogo diagnostico in continua evoluzione. È densa — ma se la segui pezzo per pezzo, vedrai che tutto si tiene.

Che cos'è la sessualità? Molto più di quello che pensi

Quando si dice "sessualità" la prima cosa che viene in mente è il sesso fisico. Ma questa è solo la punta dell'iceberg.

L'**Organizzazione Mondiale della Salute (OMS)** definisce la sessualità come:

un aspetto centrale dell'essere umano lungo tutto l'arco della vita.
Comprende il sesso, l'identità e i ruoli di genere, l'orientamento sessuale, l'erotismo, il piacere, l'intimità e la riproduzione.

La sessualità viene vissuta ed espressa in pensieri, fantasie, desideri, credenze, attitudini, valori, comportamenti, pratiche e relazioni. Ed è influenzata da fattori biologici, psicologici, sociali, politici, culturali, etici, giuridici, storici, religiosi e spirituali.

Galimberti aggiunge la prospettiva psicoanalitica: la sessualità non riguarda solo il corpo e la riproduzione. È il motore dello sviluppo psicologico e relazionale. Poiché l'attività sessuale ha bisogno dell'altro per esprimersi compiutamente, l'evoluzione della sessualità coincide con l'evoluzione dei processi relazionali. Si parte dalla prima relazione madre-bambino e si arriva alla maturità adulta, passando per simbolizzazione e sublimazione (nell'arte, nel lavoro, nella creatività).

Il corpo: Körper e Leib

Il filosofo tedesco **Husserl** introduce una distinzione fondamentale — possibile in tedesco, intraducibile in italiano con una sola parola:

- **Körper** = il corpo come oggetto, spogliato di soggettività. È il corpo dell'anatomia, della sala operatoria, il "cadavere" senza vita interiore. Il corpo che può essere usato, consumato, misurato.
- **Leib** = il corpo vissuto, quello che entra in relazione con l'altro, si apre al mondo e porta con sé l'esperienza soggettiva della persona.

Pensa a questa distinzione come alla differenza tra il tronco di un albero come "legno da costruzione" (Körper) e l'albero che cresce, reagisce all'ambiente e comunica con l'ecosistema (Leib). Nel secondo caso, c'è vita e relazione.

Questa distinzione è molto utile per capire le parafilie: in molti di quei disturbi, il corpo altrui viene vissuto come **Körper** (oggetto) anziché come **Leib** (persona con un vissuto proprio). La professoressa la porterà all'esame.

La sessualità nella storia: un veloce excursus

La professoressa ha specificato che questa parte NON è richiesta all'esame nella versione dettagliata. Vale come contesto culturale per i collegamenti.

- **Grecia antica:** visione relativamente libera, sessualità legata alla vita sociale e culturale. L'omosessualità era praticata e non stigmatizzata; era parte della mitologia e della pedagogia.
- **Roma antica:** sessualità associata al potere e al dominio. L'omosessualità era accettata, ma le dinamiche di classe e gerarchia erano centrali.
- **Cristianesimo:** nuova moralità sessuale. Il sesso è accettabile solo nel matrimonio. Il desiderio diventa peccaminoso. Il corpo è corrotto rispetto all'anima.
- **Medioevo:** controllo della Chiesa. L'unico obiettivo sessuale legittimo è la procreazione.

- **Rinascimento:** riscoperta del corpo come parte naturale dell'esistenza. Arte e libertà nelle corti — ma la morale cristiana resta dominante nella vita pubblica.
 - **Illuminismo:** la sessualità diventa oggetto di studio scientifico per la prima volta.
-

Dalla Psychopathia Sexualis al DSM-5: storia della sessuologia moderna

Questa sezione è nel giornalino (dispense). È rilevante per l'esame.

Richard von Krafft-Ebing (1886)

Nel 1886 esce la **Psychopathia Sexualis**, opera monumentale che segna la nascita della sessuologia moderna. Krafft-Ebing:

- Introduce un vocabolario scientifico sulla sessualità: perversione, feticismo, sadismo, masochismo.
- Rompe il silenzio su tematiche prima completamente ignorate.
- Descrive la sessualità come un catalogo vastissimo di orientamenti e derive.

Limiti dell'epoca: ogni manifestazione sessuale non finalizzata alla riproduzione o diversa dall'eterosessualità duale era definita "perversa". Si credeva anche che la masturbazione avesse effetti **patogenetici** (cioè che causasse debolezza fisica, epilessia, malattie mentali).

Sigmund Freud (1905)

I **Tre saggi sulla teoria sessuale** collocano la sessualità al centro dello sviluppo psichico. Per Freud:

- Le origini della sessualità sono nell'infanzia (**sessualità infantile**).
- Le fasi dello sviluppo psicosessuale sono: **orale** → **anale** → **fallica** → **latenza** → **genitale** (la più matura).
- I disturbi mentali nascono da fissazioni in uno di questi stadi.

Freud introduce la distinzione tra: - Deviazioni rispetto all'**oggetto sessuale** (es. attrazione verso qualcuno dello stesso sesso) - Deviazioni rispetto alla **meta sessuale** (tutto ciò che non è la copula tra uomo e donna — es. rapporti orali, sadismo, masochismo)

Entrambe le categorie sono alla base delle future suddivisioni delle **parafilie**.

Alfred Kinsey (anni '40-'50)

Il **Rapporto Kinsey** è il primo studio su larghissima scala (più di 18.000 intervistati) sul comportamento sessuale reale degli americani. Emerge una grande discrepanza tra comportamento effettivo (masturbazione, tradimenti, omosessualità, rapporti prematrimoniali) e quello pubblicamente accettato.

Kinsey invitava a evitare categorie discrete in bianco e nero: la natura umana è un continuum — non una divisione netta tra capre e pecore.

Masters & Johnson (anni '60-'70)

Il ginecologo **William Masters** e la psicologa **Virginia Johnson** studiano sperimentalmente la risposta sessuale umana, descrivendo il ciclo della risposta sessuale. Il loro lavoro sfata miti e rappresentazioni fantasiose sulla sessualità.

Hanno anche ispirato la serie TV *Masters of Sex*.

Le finalità della sessualità umana

Grazzottin (sessuologa italiana) identifica quattro modalità principali:

1. **Sesso amoroso** — legato a sentimenti, intimità, connessione emotiva.
2. **Sesso ricreativo** — desiderio, piacere, divertimento, slegato dall'affetto.
3. **Sesso procreativo** — desiderio di un figlio, progetto familiare.
4. **Sesso strumentale** — usato per ottenere vantaggi:
 - *personali*: tacitare ansia, solitudine, scaricare tensione
 - *relazionali*: ridurre l'aggressività del partner, ottenere attenzione
 - *oggettuali*: denaro, carriera, oggetti, facilitazioni

Il sesso strumentale è **disfunzionale** quando arreca danno a sé o a terzi. La distinzione non è sempre netta — la professoressa sottolinea che è una "zona grigia" influenzata dal contesto culturale.

Grazzottin identifica anche tre dimensioni neurologiche della sessualità: - **Cervello rettiliano** → dimensione istintuale-riproduttiva - **Sistema limbico** → dimensione emozionale-sensazionale - **Neocorteccia** → dimensione matura e relazionale

L'identità sessuale: un costrutto biopsicosociale

L'identità sessuale è composta da quattro (o cinque) dimensioni in interazione:

Dimensione	Significato
Sesso biologico	Caratteristiche fisiche assegnate alla nascita. AFAB (Assigned Female At Birth) o AMAB (Assigned Male At Birth). Comprende caratteri sessuali primari e secondari. ~1,7% della pop. è intersex
Identità di genere	La sensazione profonda e intima di sentirsi uomo, donna, o altro. Può essere fluida o non corrispondere al sesso biologico
Ruolo di genere	Comportamenti, atteggiamenti e aspettative che la società associa a uomini e donne
Orientamento sessuale	Verso chi si prova attrazione affettiva, romantica e sessuale
<i>(Espressione di genere)</i>	Come ci si mostra al mondo: abbigliamento, acconciatura, linguaggio, modo di porsi

Termini chiave: - **Cisgender**: identità di genere allineata con il sesso biologico assegnato alla nascita. - **Transgender**: identità di genere non allineata con il sesso assegnato alla nascita. - **Gender fluid**: identità che oscilla e varia nel tempo. - **Agender**: non ci si identifica in nessun genere.

Le radici psicologiche: bisogno vs. desiderio e gli snodi di Lalli

Questa parte non è nel giornalino, ma è importante per capire le parafilie.

Bisogno vs. desiderio

Il neonato vive in totale dipendenza: quando piange, il caregiver deve rispondere quasi immediatamente. Il bisogno non ammette dilazione.

Con la crescita, il bambino impara a trasformare il **bisogno** in **desiderio**: può aspettare, differire la gratificazione, lasciare che l'esperienza maturi nel tempo.

Quando il desiderio regredisce a bisogno, si instaura la **compulsività**: non c'è più riflessione, si passa direttamente all'atto.

Questo è il meccanismo alla base di molte parafilie. È come quando in un videogioco perdi il controllo del personaggio e lui agisce da solo seguendo un pattern fisso — non c'è più una scelta, solo un'esecuzione automatica.

Gli snodi di Lalli

Lo psichiatra **Nicola Lalli** identifica sei "snodi" psichici che, se superati positivamente, permettono di sviluppare una sessualità sana. **Se non vengono risolti, aprono la strada alle parafilie.**

Snodo (versione sana)	Versione patologica
Umanizzazione — riconosco che io e l'altro siamo entrambi portatori di emozioni	Disumanizzazione — l'altro viene svuotato di umanità, trattato come oggetto
Dipendenza → autonomia — da passivo e dipendente, il bambino diventa soggetto nella relazione	Il bambino resta oggetto, non si costituisce come soggetto autonomo

Snodo (versione sana)	Versione patologica
Bisogno → desiderio — capacità di differire la gratificazione	Ritorno alla compulsività, passaggio all'atto senza mediazione cognitiva
Riconoscimento reciproco — investire nell'altro e riconoscere che anche lui investe in me	L'altro non viene più riconosciuto: viene "eliminato" dalla relazione
Fantasia — sviluppo di modalità sempre nuove di relazione	Ripetitività compulsiva, impossibilità di novità
Rapporto con l'altro — accettare che l'altro è imprevedibile ma autentico	Relazione finta, teatrale, inautentica

La ricerca indica che alle origini delle parafilie ci sono spesso dinamiche precoci problematiche: caregiver con stile seduttivo-manipolatorio, indifferenza affettiva, o affettività fasulla (pseudoseduttiva — all'apparenza affettuosa, nella realtà assente).

Nota: la mancata risoluzione degli snodi si sovrappone molto ai pattern dei disturbi di personalità studiati in precedenza.

Il DSM-5 e i disturbi sessuali: tre categorie

Il **DSM-5-TR** (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, 5a edizione con revisione del testo) distingue i disturbi sessuali in tre categorie:

1. **Disfunzioni sessuali** — disturbi del ciclo sessuale (desiderio, eccitazione, orgasmo). *Non trattate nel seminario.*
 2. **Disforia di genere** — sofferenza legata all'incongruenza tra genere esperito e genere assegnato.
 3. **Disturbi parafilici** — parafilie che causano disagio o danno.
-

Disforia di genere

In passato si parlava di **Disturbo dell'identità di genere**. Ora si parla di **Disforia di genere**. Il cambio non è cosmetico: sposta l'accento dalla condizione in sé alla **sofferenza** che può accompagnarla. La transessualità esce dalla categoria dei disturbi.

Essere transgender NON equivale ad avere una disforia di genere. Una persona transgender può vivere la propria condizione serenamente. La diagnosi di disforia di genere scatta solo quando è presente una sofferenza clinicamente significativa.

Il **transessualismo** è il disallineamento tra sesso fisico e sesso psicologico vissuto dalla persona.

Una diagnosi certificata da uno psichiatra è necessaria per accedere a terapie ormonali o riattribuzione chirurgica del sesso.

Criteri DSM-5-TR per adulti e adolescenti

Criterio A: marcata incongruenza tra genere esperito/espresso e genere assegnato, della durata di almeno 6 mesi, con almeno **2** dei seguenti:

- Incongruenza tra genere esperito e caratteristiche sessuali primarie/secondarie
- Forte desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali
- Forte desiderio per le caratteristiche sessuali del genere opposto
- Forte desiderio di appartenere al genere opposto
- Forte desiderio di essere trattato come appartenente al genere opposto
- Forte convinzione di avere i sentimenti tipici del genere opposto

Criterio B: sofferenza clinicamente significativa o compromissione del funzionamento (sociale, lavorativo, o in altre aree importanti).

Disforia di genere nei bambini

Per i bambini esistono 8 criteri specifici, di cui devono essere presenti almeno 6 (più criterio B). Includono: forte desiderio di appartenere al genere opposto, preferenza per abbigliamento del genere opposto, preferenza per giochi e ruoli del genere opposto, forte avversione per la propria anatomia sessuale, ecc.

La professoressa sottolinea che porre una diagnosi in età infantile è molto delicato: l'adolescenza porta grandi cambiamenti, e c'è il rischio di interpretare come disforia di genere ciò che è ricerca di identità o desiderio di appartenere a un gruppo.

Parallelo con l'omosessualità nel DSM

Anno	Status nel DSM
1952 (DSM-I)	Nei disturbi sociopatici di personalità
1968 (DSM-II)	Classificata come deviazione sessuale (come pedofilia, necrofilia)
Metà anni '70 (DSM-III)	Spostata dalle parafilie; problema solo se il soggetto ne soffre (egodistonia)
1987 (DSM-III-R)	Derubricata anche l'omosessualità egodistonica
1992	Eliminata dall'OMS dall'elenco delle malattie

Parafilie e disturbi parafilici

La distinzione fondamentale (importantissima per l'esame)

Il **DSM-5-TR** definisce **parafilia**:

qualsiasi intenso e persistente interesse sessuale diverso dall'interesse sessuale per la stimolazione genitale o i preliminari sessuali con partner umani fenotipicamente normali, fisicamente maturi e consenzienti.

Un **disturbo parafilico** è invece:

una parafilia che causa disagio o compromissione nell'individuo, oppure una parafilia la cui soddisfazione ha arrecato o rischiato di arrecare danno a sé stessi o agli altri.

La parafilia è **necessaria ma non sufficiente** per il disturbo parafilico. Una persona può avere una parafilia e non avere un disturbo se: - non le causa sofferenza - non arreca danno ad altri - viene agita con partner consenzienti

Ogni disturbo parafilico ha: - **Criterio A** — la natura qualitativa della parafilia (es. attrazione verso bambini prepuberi) - **Criterio B** — le conseguenze negative (disagio personale, compromissione, danno a sé/altri)

La diagnosi si pone solo con **entrambi** i criteri. Con solo il Criterio A si parla di parafilia — non di disturbo.

I disturbi parafilici del DSM-5 (8 elencati)

Gli otto vengono inclusi perché relativamente più comuni e/o perché per essere soddisfatti comportano azioni dannose o reati.

1. Disturbo voyeuristico

Ricorrenti impulsi sessuali che implicano l'**osservare persone ignare** — non consapevoli di essere osservate — mentre sono nude o impegnate in attività sessuali. L'eccitazione viene proprio dalla segretezza.

Componenti voyeuristiche lievi sono normali nell'infanzia/adolescenza (curiosità). Differenza con la pornografia: nella pornografia le persone sanno di essere riprese.

2. Disturbo esibizionistico

Desiderio ricorrente e compulsivo di **mostrare i propri genitali** a persone estranee e non consenzienti, per ottenere eccitazione sessuale. Ciò che provoca piacere è la **sorpresa** nell'altro. L'esibizionista non ha intenzione di aggredire fisicamente.

L'atto è preceduto da uno stato di tensione e si conclude con l'orgasmo mediante masturbazione. Si tende a scegliere con cura il luogo e a tornarci spesso. Più frequente negli uomini.

3. Disturbo pedofilico

Ricorrenti e forti impulsi sessuali verso bambini **prepuberi**. Una delle parafilie più antiche e più spesso nascosta. **Diversamente da altre parafilie, non ha carattere compulsivo: è sostenuta da un progetto lucido e programmato.**

La persona con disturbo pedofilico tende a scegliere professioni con accesso a bambini e un ruolo di ascendente. Spesso la persona è stata a sua volta vittima di abuso infantile.

Krafft-Ebing distingueva già pedofilia da **efebofilia** (attrazione per adolescenti 15-19 anni). Il termine usato oggi è **ebefilia** per l'attrazione verso adolescenti in fase puberale.

La presenza della pedofilia tra le parafilie (e non direttamente tra i disturbi) ha generato forti controversie: se il desiderio non viene agito, tecnicamente resterebbe nell'area della parafilia senza diagnosi di disturbo.

4. Disturbo feticistico

Ricorrenti e intensi impulsi sessuali legati a **oggetti inanimati o particolari parti del corpo** (non genitali). Oggetti comuni: biancheria intima, calze, scarpe, stivali; parti del corpo: piedi (i più citati in letteratura).

Il feticcio deve essere investito di un **valore specifico** per quella persona. È possibile avere più parafilie contemporaneamente.

5. Disturbo da travestitismo

Impulso sessuale intenso e compulsivo a **travestirsi con abiti del sesso opposto**. Non va confuso con: - **l'identità transgender** (non c'è eccitazione sessuale

nel vestirsi come il genere in cui ci si identifica) - le drag queen (performance artistica, non necessariamente sessuale)

A volte si manifesta indossando biancheria intima del sesso opposto sotto i propri abiti.

6. Disturbo da masochismo sessuale

Eccitazione sessuale derivante dall'essere **umiliati, legati, fatti soffrire o percossi**. Il DSM specifica la variante con **asfissiofilia** (eccitazione tramite limitazione della respirazione/soffocamento), che può essere molto pericolosa e ha causato decessi.

7. Disturbo da sadismo sessuale

Eccitazione sessuale derivante dall'**infliggere sofferenza** fisica o psicologica ad altri. Con partner consenziente rimane nell'area della parafilia; diventa disturbo se causa danno o manca il consenso.

Masochismo = piacere nel farsi fare male. Sadismo = piacere nel fare male a qualcun altro.

8. Disturbo frotteuristico

Impulso a **toccare o strusciare** i propri genitali contro una persona non consenziente per ottenere eccitazione sessuale. **Avviene tipicamente in contesti affollati: autobus, concerti, stadi.**

Don Giovanni come specchio clinico

Il materiale del seminario include un saggio di **Lorenzo Pezzoli** sulla regia di **Graham Vick** del Don Giovanni di Mozart (Teatro Sociale di Como, 2014). Vale la pena capirlo perché integra tutto quello che si è visto.

In questa messa in scena, Don Giovanni non è il seduttore affascinante della tradizione: è un uomo che usa le persone come oggetti — Körper, mai Leib. Usa ogni persona per ricavarne ciò che vuole (piacere, servizi, divertimento) e non lascia nemmeno quella vita che Barbablù fisicamente toglie.

Come scrive il regista Vick: "Don Giovanni si diffonde come un virus... la trasgressione è glamour, è vendibile, provoca dipendenza e la corruzione è norma condivisa."

Il punto clinico di Pezzoli: la ripetizione seriale dell'atto non porta più piacere, solo sollievo. È la struttura classica della dipendenza. Il tempo svanisce in un eterno presente uguale a sé stesso. Non c'è nessuno degli snodi di Lalli risolti: niente umanizzazione, niente riconoscimento reciproco, niente fantasia — solo la compulsività del bisogno.

Alla fine della regia, Don Giovanni non scende nell'inferno tra le fiamme: si siede tra il pubblico in sala. E questo è il messaggio più inquietante: Don Giovanni non è lontano, è uno di noi ogni volta che siamo indifferenti, cinici, disattenti all'altro.

Cosa ti chiederanno all'esame

La professoressa ha indicato esplicitamente i temi d'esame:

- **Definizione di sessualità** (OMS + Galimberti)
 - **Distinzione Körper / Leib** e collegamento con le parafilie
 - **Sviluppo storico della sessuologia** (Krafft-Ebing, Freud, Kinsey — quello che c'è nel giornalino)
 - **Componenti dell'identità sessuale** (le quattro dimensioni)
 - **Disforia di genere**: definizione, differenza con il vecchio "disturbo dell'identità di genere", criteri A e B, differenza con essere transgender
 - **Parafilie vs. disturbo parafilico**: la distinzione fondamentale con criteri A e B
 - **I disturbi parafilici** (anche come vignetta clinica: "descrivi un caso e colloocalo")
-

Concetti chiave

Termine	Significato
Körper	Il corpo come oggetto, privo di soggettività (anatomia, cadavere)
Leib	Il corpo vissuto, che si relaziona con il mondo
Parafilia	Interesse sessuale intenso e persistente verso oggetti/ situazioni non convenzionali
Disturbo parafilico	Parafilia che causa disagio personale o danno a sé/altri
Disforia di genere	Sofferenza legata all'incongruenza tra genere esperito e genere assegnato
Cisgender	Identità di genere allineata con il sesso biologico assegnato
Transgender	Identità di genere non allineata con il sesso biologico assegnato
Efebofilia / Ebefilia	Attrazione sessuale verso adolescenti in fase puberale
Asfissiofilia	Variante del masochismo sessuale con eccitazione tramite soffocamento
Frotteurismo	Eccitazione tramite contatto fisico non consenziente in luoghi affollati
Egodistonia	Condizione vissuta con disagio dal soggetto stesso
Patogenetico	Che genera/causa patologie

Domande di orientamento allo studio

1. Come definisce la sessualità l'OMS, e cosa aggiunge Galimberti a questa definizione?

L'**OMS** definisce la sessualità come un aspetto centrale dell'essere umano lungo tutto l'arco della vita, che comprende sesso, identità e ruoli di genere, orientamento sessuale, erotismo, piacere, intimità e riproduzione — influenzata da fattori biologici, psicologici, sociali, culturali, giuridici, storici e spirituali. **Galimberti** aggiunge la prospettiva psicoanalitica: la sessualità non riguarda solo il corpo, ma è il motore dello sviluppo psicologico e relazionale. Poiché ha bisogno dell'altro per esprimersi, l'evoluzione della sessualità coincide con l'evoluzione della capacità di relazione — dalla prima relazione madre-bambino fino alla maturità adulta, attraverso simbolizzazione e sublimazione.

2. Qual è la distinzione tra Körper e Leib, e perché è rilevante per comprendere le parafilie?

Körper (Husserl) è il corpo come oggetto, privo di soggettività: il corpo dell'anatomia, misurabile, consumabile. **Leib** è il corpo vissuto, che entra in relazione con l'altro e porta con sé l'esperienza soggettiva della persona. **La distinzione è clinicamente cruciale per le parafilie: in molti di questi disturbi il corpo altrui viene trattato come Körper (oggetto su cui agire) anziché come Leib (persona con un vissuto proprio). L'assenza di riconoscimento dell'altro come soggetto è il nucleo relazionale della patologia.**

3. Quali sono le quattro componenti dell'identità sessuale?

1. **Sesso biologico** — caratteristiche anatomiche e cromosomiche (maschio/femmina/intersex)
2. **Identità di genere** — il senso interno di sé come uomo, donna o altro, indipendentemente dal sesso biologico
3. **Ruolo di genere** — i comportamenti, atteggiamenti e aspettative socialmente attribuiti a un genere
4. **Orientamento sessuale** — l'attrazione emotiva, romantica e/o sessuale verso persone di un determinato sesso/genere

Questi quattro livelli sono indipendenti tra loro: qualsiasi combinazione è possibile.

4. Cos'è la disforia di genere? Quali sono i criteri A e B, e in cosa si distingue dall'essere transgender?

La **disforia di genere** (DSM-5-TR) è la sofferenza clinicamente significativa legata all'incongruenza tra il genere esperito/espresso e il genere assegnato alla nascita.

Criterio A: incongruenza marcata e persistente tra genere esperito e genere assegnato. **Criterio B:** la condizione causa disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento (lavorativo, sociale, ecc.). **La distinzione con il transgender è fondamentale: essere transgender è un'identità, non una diagnosi.** La diagnosi di disforia di genere si pone solo quando c'è sofferenza. Una persona transgender che vive serenamente la propria identità non ha disforia di genere.

5. Qual è la differenza tra parafilia e disturbo parafilico?

Una **parafilia** è un interesse sessuale intenso e persistente verso oggetti, situazioni o persone inusuali (es. feticismo, voyeurismo, ecc.). Di per sé non è una diagnosi. Diventa un **disturbo parafilico** quando soddisfa il criterio B: causa disagio personale significativo al soggetto stesso, oppure comporta danno ad altri (specie se non consenzienti). In pratica: la parafilia riguarda cosa eccita; il disturbo riguarda le conseguenze di quell'eccitazione su sé stessi o sugli altri.

6. Elenca i principali disturbi parafilici del DSM-5 e descrivine brevemente uno con una vignetta clinica.

I disturbi parafilici principali sono: voyeuristico, esibizionistico, frotteuristico, masochismo sessuale, sadismo sessuale, pedofilico, feticistico, travestitico.

Vignetta (frotteurismo): Un uomo di 34 anni riferisce un impulso ricorrente e incontrollabile a strusciare i propri genitali contro persone non consenzienti sui mezzi pubblici. L'atto lo eccita sessualmente. Prova vergogna intensa dopo, ma non riesce a trattenersi. Il disagio soggettivo (criterio B) e il coinvolgimento di persone non consenzienti confermano la diagnosi di disturbo frotteuristico.

Collegamenti

- **Lezioni precedenti:** disturbi di personalità (la compulsività e le difficoltà a modulare gli impulsi nelle parafilie riecheggiano quei pattern); fasi di sviluppo psicosessuale di Freud (già affrontate).
- **Lezione successiva:** corpo violato (si collegherà direttamente alla dimensione del Körper e all'uso strumentale del corpo altrui).
- **Da approfondire:** ruolo del contesto culturale nella definizione di "normalità" sessuale; etnopsichiatria e differenze cross-culturali (accennate ma non trattate per mancanza di tempo).